PROTOCOLLO 29

Mobilizzazione con movimento in apertura

Combinare uno scivolamento passivo con l'apertura attiva del paziente

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore durante l'apertura
- ✓ Deviazione in apertura
- ✓ Risposta positiva ai test di scivolamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto, schiena appoggiata.

Fisioterapista: dietro al paziente, mani esterne sui rami mandibolari.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Paziente seduto, terapista dietro, mani sui rami mandibolari.



Scivolamento
Applica uno scivolamento laterale correttivo del lato deviato.



Movimento attivo
Il paziente apre lentamente mantenendo la correzione.



Criterio
Il movimento deve essere senza dolore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	6 a 10
Serie	3
Criterio	assenza di dolore

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ La regola è nessun dolore durante il movimento
- ✓ Osserva la traiettoria allo specchio
- ✓ Trasforma la tecnica in autotrattamento

Errori da evitare

- ! Continuare se compare dolore
- ! Correzione eccessiva
- ! Movimento troppo rapido

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura con autocorrezione	Mano sul lato deviato guida l'apertura retta	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La mobilizzazione con movimento consente un controllo immediato dell'effetto sintomatico.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.